

21. IL LEGAMENTO DI LILIEQUIST

DURATA : 07:37

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora l'anatomia e i meccanismi del legamento di Liliequist, una struttura essenziale che agisce come un diaframma a livello del terzo ventricolo. Si apprende come questo legamento interagisce con il nervo oculomotore e il tronco basilare, influenzando così il sistema ventricolare e l'ipofisi. Vengono affrontati i concetti di tensioni membranose, assi di movimento cranico e il loro impatto sui sistemi facciali e ormonale, sottolineando l'importanza dei movimenti cranio-sterno-sacrali e mandibolari. L'analisi delle tensioni può anche aiutare a diagnosticare disfunzioni a livello occlusale, offrendo chiavi terapeutiche per ripristinare l'armonia corporea.

IL LEGAMENTO DI LILIEQUIST: ANATOMIA E MECCANISMI

Il **legamento di Liliequist** è una struttura anatomica che agisce come un piccolo diaframma, comunemente chiamato **membrana di Liliequist**. Questo legamento si inserisce a livello del **terzo ventricolo** e scende fino allo **sfenoide**. In questo punto, svolge un ruolo cruciale in relazione al **nervo oculomotore** e al passaggio arterioso, in particolare il **tronco basilare**, responsabile della formazione delle **arterie cerebrali**.

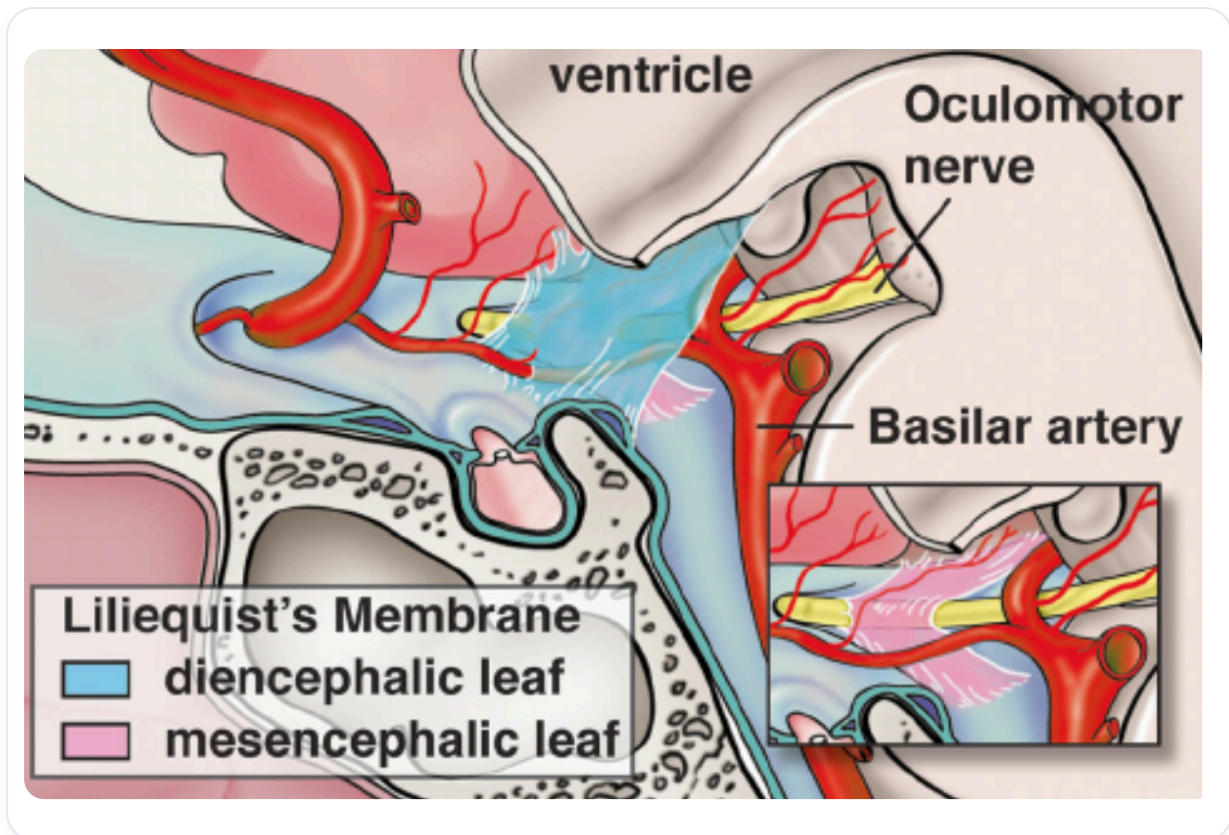


FIG. — Legamento di Liliequist

Quando il legamento scende, crea un **asse di tensione** che influenza il **sistema ventricolare**. Il terzo ventricolo, il quarto ventricolo, così come i **ventricoli laterali** sono tutti interconnessi da questa dinamica. Si instaura uno schema di tensione che ha un impatto significativo sullo spazio in cui si trova l'**ipofisi**.

Sopra l'ipofisi si trova il **chiasma ottico**, orientato a circa 30 gradi, con un movimento posturale di 5 gradi. Questo movimento è essenziale per il **drenaggio** tra il terzo ventricolo, lo sfenoide e i **micro-vasi** circostanti. I **periciti**, presenti nei microcapillari, interagiscono con i nervi, creando **spazi emato-encefalici** che agiscono come un punto di appoggio profondo.

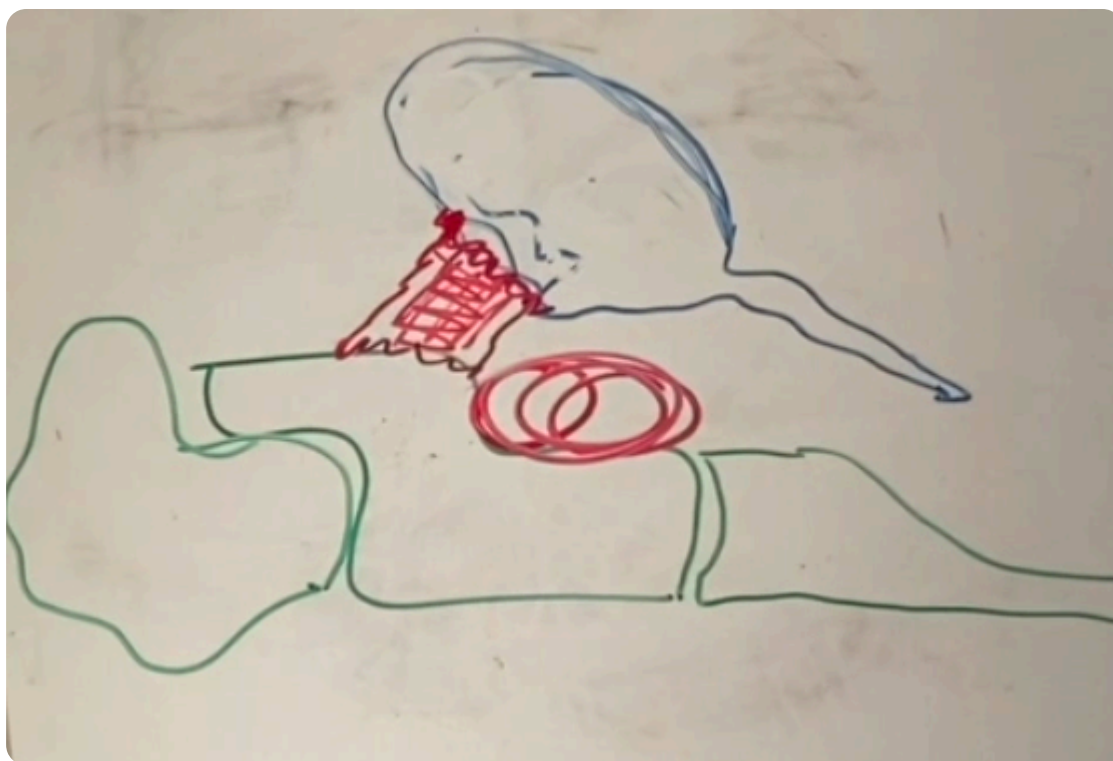


FIG. — Sistema ventricolare

Esaminando i **presfenoidi**, che corrispondono all'**occipite**, si osserva uno spazio di bilanciamento sulla membrana di Liliequist. Questa tensione membranosa influenza sia i nervi che i vasi sanguigni, e si trova in prossimità dell'ipofisi, dove il sistema nervoso comunica con il sistema ormonale tramite l'**asse ipotalamo-ipofisi-tiroide-surrene-gonadi**.

Anche il movimento cranico è importante da considerare. Osservando un cranio, si possono notare i diversi movimenti a livello dei **parietali** e di altre strutture. Questi movimenti seguono linee di forza specifiche. Ad esempio, il movimento di **flessione** a livello frontale, associato alla **sutura metopica**, rappresenta due punti di bilanciamento che influenzano il movimento dell'occhio.

È cruciale comprendere che il **cervello** condiziona il **sistema ventricolare** e il **sistema facciale**, sia a livello del **condrocranio** (cartilagine) che del **desmocranio** (membrana). Durante lo sviluppo, quando l'**occipite** scende, anche il **sacro** scende, e i **temporali** svolgono un ruolo chiave in questa dinamica.

Lo **sterno** sale in risposta a questi movimenti, convergendo verso la linea mediana anteriore. Tutto ciò è inscritto nell'occhio, ed è essenziale aggiungere elementi riguardanti il sistema facciale e il sistema capsulare dell'occhio, che si inseriscono intorno e organizzano l'insieme con una controrotazione a livello dello sviluppo dell'orbita.

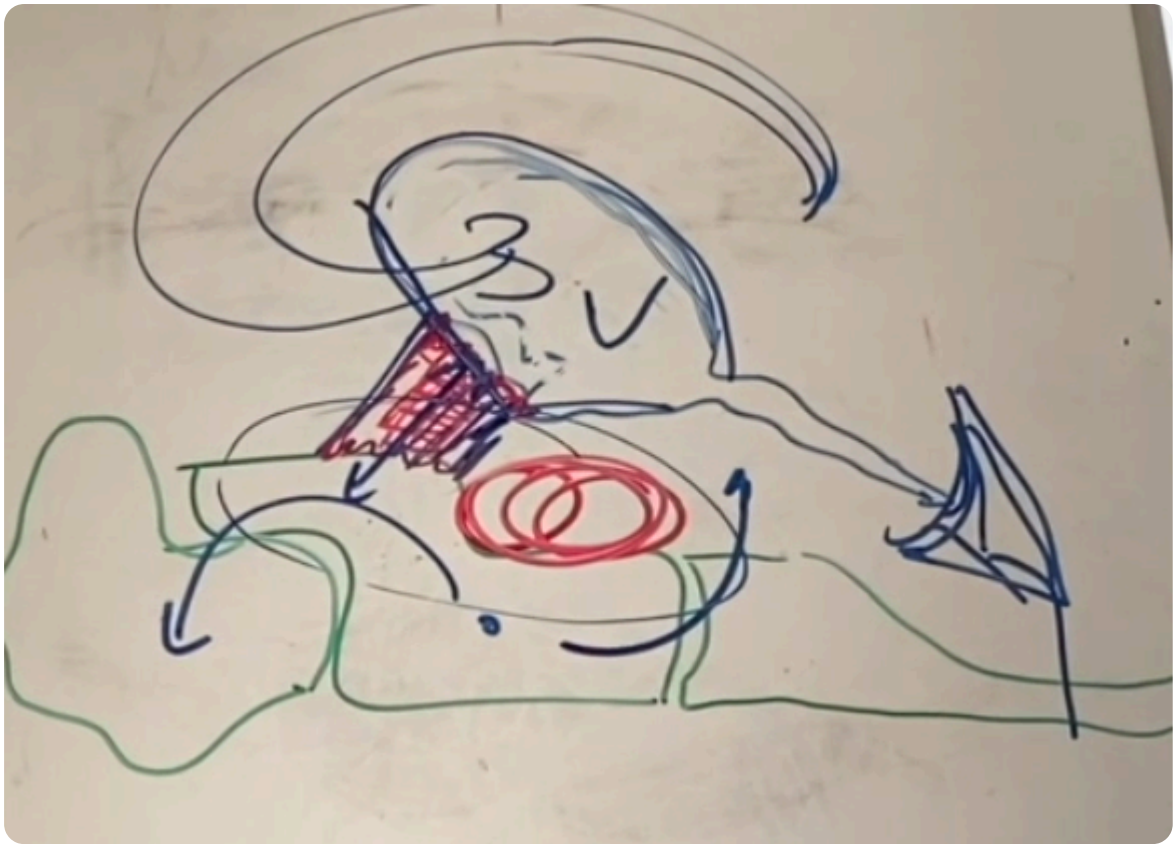


FIG. — *Movimenti cranici*

I movimenti cranio-sterno-sacrali e mandibolari sono interconnessi. Anche gli assi canini sono importanti, poiché influenzano l'**occlusione**. Se l'incontro canino superiore e inferiore non è corretto, ciò comporta una perdita di informazioni a livello del cervello, poiché questi campi elettrici devono unirsi.

L'**occlusione** è quindi il riflesso delle tensioni presenti sulla **sinfisi sfeno-basilare**. Osservando i denti, è possibile determinare la presenza di **strain** (tensione), che sia verticale, laterale o altro. Ciò permette di comprendere le costrizioni e di aggiustare i trattamenti necessari per ristabilire l'equilibrio.

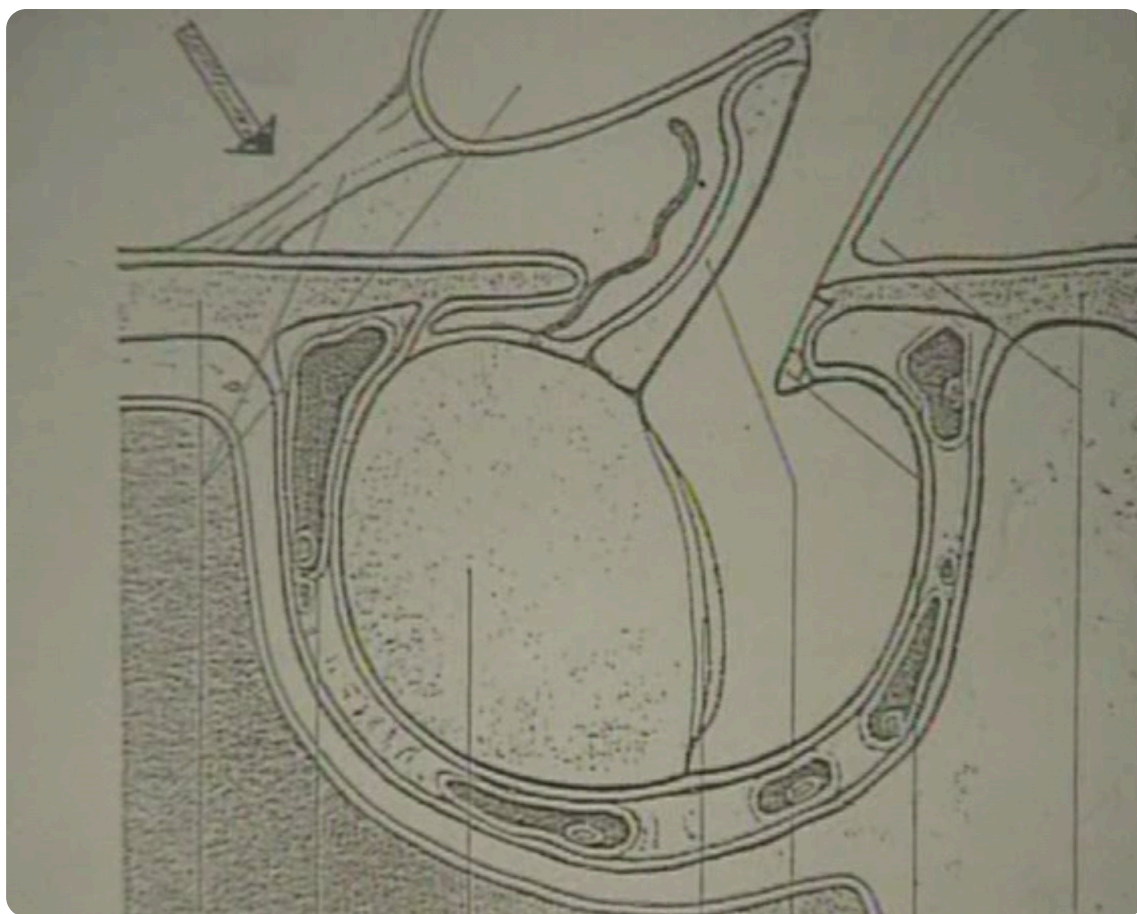


FIG. — *Movimenti coordinati del cranio, sterno e sacro*